



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : مروه محمد محمد صابر

المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : الدرب الأحمر العنوان : ---

رقم البطاقة : 29309040102744 رقم التليفون : 01124685491 تاريخ تسجيل الإستمارة : 29-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 04-09-1993 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /..... /د. /..... /د. /..... /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: مروه محمد محمد صابر National ID: 29309040102744	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



مروء
محمد محمد صابر
٢١ ش النبويسوق السلاح
الدرب الأحمر - القاهرة

٢٩٩٢/٠٢/٩١ ٢٩٢٠٩٠٤٠١٠٢٧٤٤
176158436

DMS
ند كس

٢٠٢١/٠٢/٩١ ٢٩٢٠٩٠٤٠١٠٢٧٤٤

بدون عمل

أنثى
مستلمة
رامي محمود سيد محمد
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٢/٩٢





Patient Name : الأستاذ / مروه محمد محمد صابر
Patient No. : 29309040102744
Path No. : 181/26
Sex : Female
Age : 32 Y
Referring Doc :

Request No. : 13004608
Request Date : 20/01/2026
Verification Date : 03/02/2026
Financial Category : جوسفات روسي - مياجره
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast multicentric mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 20/01/2026, at 13:10 pm, cold ischemia time: 20 seconds.

Gross Examination:

- Four fragmented grey white tissue cores, the longest is 1.5 cm. Totally submitted.

Technique:

- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade 3 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 3, mitosis 2).
- * Ductal carcinoma in situ: Absent.
- * Angioinvasion: Absent.
- * Perineural invasion: Absent.
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Moderate nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 7/8).
- PR: Moderate nuclear reaction in 60% of tumor cells (score 6/8).
- Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 60%.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, Grade 3.

IPT:

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed



Name: <u>مروه محمد محمد صابر</u>		
MR. : <u>8911</u>		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحية طيبة وبعد,,		
إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:	رقم طبي:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
تاريخ وساعة الدخول :	تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient was evaluated for a newly diagnosed breast cancer and a decision was made to initiate neoadjuvant chemotherapy (NACT) as planned today. The patient has left-sided breast cancer that is hormone-receptor positive and HER2-negative, clinical stage cT3N2. The planned neoadjuvant regimen consists of 4 cycles of AC (doxorubicin and cyclophosphamide) followed by 4 cycles of taxane (TXT) with concurrent Zoladex. The patient's weight is 94 kg, height 165 cm, and baseline absolute neutrophil count (ANC) is $2 \times 10^9/L$. Full-dose chemotherapy will be administered with prophylactic G-CSF (2 ampules given 48 hours after chemotherapy). An echocardiogram performed on 25 April showed an ejection fraction of 66 % (baseline). Laboratory values on the day of the first AC cycle demonstrated a total leukocyte count (TLC) of $3.15 \times 10^9/L$ and ANC of $1.2 \times 10^9/L$; primary prophylaxis with G-CSF was initiated. On 30 June the patient was noted to have left-sided breast cancer, clinical stage cT3N2, with pathology revealing ER 7/8, PR 8/8, HER2-negative, Ki-67 60 %. The patient was neutropenic, prompting a one-week postponement of chemotherapy. On 4 July the patient was scheduled for cycle 4 of AC. At that time the patient was neutrophilic with leukocytosis. The next planned taxane (Taxotere) dose was to be given every 21 days, with continuation of Zoladex if approved, and a request was made to add methotrexate. A bone scan performed on 24 July showed uneven tracer uptake at the manubrium sterni, prompting recommendation for CT correlation. Physical examination revealed a left breast mass measuring 4 × 5 cm, a left lower outer quadrant mass 2 × 3 cm, and left axillary lymph nodes 2 × 3 cm. The patient was scheduled for cycle 1 of neoadjuvant Taxotere at 150 mg. On 3 August the patient reported fatigue, generalized bony aches, and diarrhea (grade II). Oral mucositis was noted. The treating team decided to reduce the TXT dose by 10 % to 135 mg. On 17 August the neoadjuvant regimen was summarized as AC × 4 plus TXT × 4. A bone scan on 7 August suggested a solitary sternal lesion, and a CT chest was ordered for further evaluation. The patient was noted to be on cycle 2 of TXT. On 3 September the patient, known to have left breast cancer, complained of localized neuropathic pain. Analgesia with tramadol 50 mg every 12 hours and gabapentin 150 mg every 12 hours was prescribed. On 8 September the patient was suspected to have oligometastatic bone disease and was awaiting a multidisciplinary decision. In the interim, treatment		
تحريراً في ,		
التاريخ :	21-09-2026	الوقت :
الطبيب المعالج :		Ali Adel
يعتمد ,		

was continued for cycle 3 of TXT, and laboratory studies were accepted. The patient has now completed three cycles of TXT.

Patient Name : الأستاذ / مروه محمد محمد صابر
Patient No. : 29309040102744
Path No. : 181/26
Sex : Female
Age : 32 Y
Referring Doc :

Request No. : 13004608
Request Date : 20/01/2026
Verification Date : 03/02/2026
Financial Category : جريساتف روسي - مبادره
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- ER: Positive (score 7/8).
- PR: Positive (score 6/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67%: 60%.

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%

and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0 (Ultra-low) membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.

Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

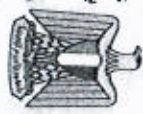
Printing Date : 14/02/2026 12:16:08

Page 2 of 3

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



٢٠٢١/٠٣ ٢٤٣٠٩٠٤٠١٠٢٧٤٤
 بدون عمل
 إني مبنية
 رامي محمود سيد محمد
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٩/٢٣
 ١


جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية
 مروه
 محمد محمد صابر
 ٢١ ش. الثورة يسوق السلاح
 العرب الأحمر - القاهرة
 ٢٩٣٠٩٠٤٠١٠٢٧٤٤
 IT6158436